

細胞障害性抗がん薬:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 細胞障害性抗がん薬の薬薬連携 — 経口薬と制吐薬

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
1 体表面積・腎機能・累積投与量から投与量を監査 2 催吐性リスクに応じた制吐薬と、持ち帰り分の処方設計 3 抗がん薬の調製と、血管外漏出への対応 4 アントラサイクリン累積量と心エコーの予定を管理 5 減量・延期の理由を情報提供書などで薬局へ伝達	減量・延期の理由 (投与量の変更) 累積投与量 (アントラサイクリン等) 持ち帰りの制吐薬 (日数・服用日) 口内炎・しびれの程度 (次コースの判断材料)	1 S-1・カベシタビンの服用日と休業日を暦で確認 2 持ち帰りの制吐薬(デキサメタゾン等)の服用日を具体的に説明 3 処方箋の検査値で腎機能・好中球数の推移を確認 4 退院後に追加されたNSAIDs・PPIを確認(腎障害・メトトレキサート) 5 経口抗がん薬は粉砕しない、投与後の排泄物の扱いを説明

2 投与量と臓器機能 — 薬局で確認できること

カルボプラチン	シスプラチン	ドキソルビシン
病院で確認する値・上限 目標AUCと腎機能(カルバート式:AUC×(GFR+25)) 理由 GFRの推定方法で投与量が大きく変わる 保険薬局での活用 処方箋の検査値でクレアチニンの推移を確認	病院で確認する値・上限 腎機能(CCr)、補液量、Mg補充 理由 腎障害の予防 保険薬局での活用 尿量・むくみ・水分摂取を聴取、NSAIDsの新規処方に注意	病院で確認する値・上限 累積投与量 500mg/m ² (他のアントラサイクリン系は換算して通算) 理由 超えると心不全のリスクが上昇 保険薬局での活用 治療歴を通算で把握し、息切れ・むくみを聴取
プレオマイシン	メトトレキサート(大量療法)	イリノテカン
病院で確認する値・上限 総投与量 300mg(力価) 理由 総量に依存して肺線維症のリスク 保険薬局での活用 乾性咳嗽・息切れを聴取	病院で確認する値・上限 血中濃度、尿pH、ホリナート救済 理由 排泄遅延で重篤な副作用 保険薬局での活用 退院後のNSAIDs・PPIの新規処方に注意	病院で確認する値・上限 UGT1A1*6/*28の遺伝子多型 理由 ホモ・複合ヘテロで減量を検討 保険薬局での活用 結果を薬歴に記録し、下痢・発熱の指導を強化

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書併用禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カベシタビン・5-FU等)	5-FU濃度↑→重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意 添付文書警告	カベシタビン・S-1 CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR↑(出血)・フェニトイン中毒	INR測定を頻度を処方医と確認
注意 添付文書併用注意	メトトレキサート 腎排泄の遅延	処方薬 市販薬 NSAIDs・PPI・ST合剤(市販の解熱鎮痛薬も)	MTX濃度↑→骨髄抑制・粘膜障害	市販の解熱鎮痛薬の使用も聴取
注意 添付文書併用注意	イリノテカン CYP3A4阻害	処方薬 アゾール系抗真菌薬	SN-38↑→骨髄抑制・下痢↑	他院の抗真菌薬の処方を確認
注意 添付文書用法・用量	FTD/TPI 空腹時は吸収が増加	生活習慣 空腹時の服用	好中球減少が増強	朝・夕の食後に服用するよう指導
確認 服薬指導上の注意	細胞障害性・抗がん薬全般 発熱を隠す	市販薬 市販の解熱鎮痛薬・かぜ薬	発熱性好中球減少症の発見の遅れ	服用前に体温を測り、発熱時は連絡

4 服薬指導タイムライン — 1コースの流れと累積毒性

① 治療開始前	② 投与当日～5日	③ 投与後1～2週	④ コースを重ねたら
“髪は2～3週目から抜け始めることが多いので、ウィッグや帽子を早めに準備しておくとう安心です” ✓ 薬局で確認 お薬手帳でレジメン・投与日、他院処方・市販薬・サプリ △ ここに注意 口乾ケア・歯科受診は治療前に済ませておく	“吐き気止めは、吐き気がなくても決められた時間に飲んでください。2～5日目の吐き気にも備えましょう” ✓ 薬局で確認 制吐薬の服用状況、水分・食事量 △ ここに注意 水分がとれない・尿が少ない時は至急連絡	“37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずにすぐ病院へ。手洗い・うがいもこまめに” ✓ 薬局で確認 nadir期の発熱・口内炎 △ ここに注意 発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診	“息切れやむくみ、手足のしびれなど、回数を重ねて出てくる症状はありませんか” ✓ 薬局で確認 アントラサイクリンの累積量、しびれの程度、処方箋の腎機能 △ ここに注意 息切れ・むくみ・急な体重増加は心不全を疑い受診